

Depresyon (Depresif Bozukluk)

Depresyon, yalnızca zaman zaman üzgün veya mutsuz hissetmekten farklı olan, kişinin duygu durumunu, düşüncelerini ve günlük yaşamını etkileyen yaygın bir ruhsal bozukluktur. Her insan zaman zaman üzülebilir, stres yaşayabilir veya keyifsiz hissedebilir. Ancak depresyonda bu durum geçici değildir; en az iki hafta boyunca, günün büyük bölümünde ve neredeyse her gün devam eden çökkün ruh hali ya da daha önce keyif veren şeylere karşı ilgi ve zevk kaybı görülür. Bu belirtiler kişinin okul, iş, aile ve sosyal yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir.

Depresyon her yaşta ve farklı yaşam koşullarındaki kişide görülebilir. Dünya genelinde yüz milyonlarca insanı etkilediği tahmin edilmektedir ve kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Bununla birlikte erkeklerde depresyonun fark edilmesi daha zor olabilir. Bazı erkeklerde üzüntüden çok öfke, huzursuzluk, içine kapanma, riskli davranışlarda artış veya alkol ve madde kullanımında artış gibi belirtiler ön plana çıkabilir. Çocuklarda ve gençlerde ise depresyon her zaman açık bir üzüntü şeklinde görülmeyebilir; sinirlilik, okul sorunları, huzursuzluk veya sosyal olarak geri çekilme şeklinde ortaya çıkabilir.

Depresyonun tek bir nedeni yoktur. Biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin birbiriyle etkileşimi hastalığın ortaya çıkmasında rol oynar. İşsizlik, ağır kayıp, travmatik yaşantılar, uzun süreli stres ve sosyal sorunlar depresyon riskini artırabilir. Bunun yanında genetik özellikler, bazı biyolojik süreçler ve kişinin içinde bulunduğu çevre de etkili olabilir. Depresyon ile fiziksel hastalıklar arasında da yakın bir ilişki vardır. Kalp hastalıkları, diyabet, kanser ve kronik ağrı gibi sağlık sorunları depresyon riskini artırabilir; depresyon da kişinin fiziksel sağlığını ve mevcut hastalıklarla baş etmesini zorlaştırabilir.

Depresyonun belirtileri kişiden kişiye değişebilir. En sık görülen belirtiler arasında sürekli üzgün, boş veya umutsuz hissetme; daha önce keyif alınan aktivitelere karşı ilgi ve zevk kaybı; yorgunluk ve enerji azalması; dikkat ve karar verme güçlüğü; uyku bozuklukları; iştah ve kilo değişiklikleri; suçluluk, değersizlik veya çaresizlik duyguları bulunur. Bazı kişilerde baş ağrısı, sindirim sorunları veya açıklanamayan fiziksel ağrılar da görülebilir. Daha ağır durumlarda ölüm veya intihar düşünceleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle depresyon yalnızca “moral bozukluğu” olarak görülmemeli, kişinin yaşamını ve güvenliğini etkileyebilen ciddi bir sağlık sorunu olarak ele alınmalıdır.

Depresyon farklı biçimlerde görülebilir. Majör depresyon, genellikle en az iki hafta süren ve günlük yaşamı belirgin şekilde etkileyen depresif belirtilerle karakterizedir. Kalıcı depresif bozukluk (distimi) ise daha uzun süre devam eden, genellikle daha hafif fakat sürekli depresif belirtileri ifade eder. Ayrıca mevsimsel özellik gösteren depresyon, psikoz belirtilerinin eşlik ettiği depresyon ve doğumla ilişkili depresif

durumlar gibi farklı tablolar da bulunmaktadır. Bipolar bozuklukta ise depresif dönemler, aşırı enerjik veya taşkın ruh haliyle seyreden mani ya da hipomani dönemleriyle birlikte görülür. Bu nedenle depresyon değerlendirilirken kişinin geçmişte yaşadığı ruh hali değişikliklerinin de dikkate alınması önemlidir.

Depresyon tanısı yalnızca tek bir belirtiyeye bakılarak konulmaz. Sağlık uzmanı belirtilerin ne zaman başladığını, ne kadar sürdüğünü, günlük yaşamı ne ölçüde etkilediğini ve başka sağlık sorunlarının bulunup bulunmadığını değerlendirir. Bazı ilaçlar ve tiroid bozuklukları gibi bazı tıbbi durumlar depresyona benzeyen belirtilere neden olabileceğinden, gerekli durumlarda fiziksel muayene ve çeşitli testler de yapılabilir.

Depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavi kişinin belirtilerinin şiddetine, ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre planlanır. Psikoterapi, özellikle hafif depresyonda önemli bir tedavi seçeneğidir. Bilişsel davranışçı terapi ve kişilerarası terapi gibi yöntemler kişinin olumsuz düşünce ve davranışlarını fark etmesine, sorunlarla daha sağlıklı baş etmesine ve ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Orta ve şiddetli depresyonda antidepresan ilaçlar psikoterapiyle birlikte kullanılabilir. Tedaviye yanıt vermeyen veya çok ağır seyreden bazı durumlarda ise

elektrokonvulsif terapi (ECT) veya tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS) gibi beyin stimülasyon yöntemleri değerlendirilebilir.

Tedavinin yanında günlük yaşamda yapılabilecek bazı şeyler de destekleyici olabilir. Düzenli uyku ve beslenme, fiziksel aktivite, mümkün olduğunca sosyal ilişkileri sürdürmek ve güvenilen kişilerle duyguları paylaşmak önemlidir. Alkol ve uyuşturucu kullanımından uzak durmak da belirtilerin kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir. Ancak kişinin kendisini zorlayarak her şeyi tek başına çözmeye çalışması gerekmez; depresyon bir irade zayıflığı değildir ve profesyonel yardım almak iyileşmenin önemli bir parçasıdır.

Sonuç olarak depresyon, geçici bir üzüntü halinden çok daha fazlasıdır. Kişinin duygularını, düşüncelerini, bedenini, ilişkilerini ve günlük işlevlerini etkileyebilen; ancak uygun destek ve tedaviyle iyileşme sağlanabilen bir ruhsal bozukluktur. Belirtilerin uzun süre devam etmesi veya kişinin yaşamını belirgin biçimde etkilemesi durumunda bir sağlık uzmanından yardım alınması önemlidir.

Kaynaklar:

- 1) World Health Organization. (2025, August 29). *Depressive disorder (depression)*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- 2) World Health Organization. Creating awareness on prevention and control of depression <https://www.who.int/thailand/activities/creating-awareness-on-prevention-and-control-of-depression>
- 3) National Institute of Mental Health. (2025). *Depression*. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. <https://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression>

Ali Bocakkıtay/ Founder, Wionpav Labs/ Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University